

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЭКСТРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ

Пациент: **Рамзес** (Кане-Корсо, 11 лет) | Сочетанная патология: **Хилоторакс / Лимфома + ХБП Stage 2 IRIS**

Назначение аптечки: Комплект предназначен для домашнего купирования побочных эффектов химиотерапии (протокол СНОР), контроля почечной функции (ХБП 2 стадии) и снятия костно-нейропатической боли. Все препараты применяются по согласованию с лечащим врачом.

1. Лекарственные препараты домашней аптечки

Препарат / Форма	Дозировка и Схема	Показания к применению	Специальные инструкции / Ограничения
Серения (Маропитант) Таб. 16/24/60 мг	2 мг/кг PO 1 раз в сутки (SID)	Противорвотное. Применяется за 1 час до введения циклофосамида/доксорубицина или при тошноте/слюнотечении.	Безопасен при ХБП 2 стадии. Применять при первых признаках подташнивания или отказе от корма.
Омепразол (Омез) Капсулы 10/20 мг	1 мг/кг PO 1 раз в сутки (утром за 30 мин до еды)	Гастропротектор. При утренней тошноте, уремическом гастрите при ХБП и для защиты ЖКТ при приеме преднизолона.	Капсулу не разжёвывать. При появлении черного стула (мелены) — немедленный вызов врача!
Габапентин Капсулы 100/300 мг	По назначению Каждые 12 часов (08:00 и 20:00)	Анальгезия при костном дискомфорте и нейропатической боли. Поддержка качества жизни.	Выводится почками. Категорически нельзя отменять резко! При седации — коррекция дозы врачом.
Фуросемид Таблетки 40 мг	1-2 мг/кг PO Утром в день Циклофосамида	Форсированный диурез для уропротекции при приеме циклофосамида (вымывание акролеина).	Давать строго утром вместе с циклофосамидом. Обеспечить обильное питье и выгул каждые 2 часа.
Энрофлоксацин (Байтрил) Таблетки 50/150 мг	10 мг/кг PO SID Курс 5 дней (по назначению)	Антибиотик резерва при миелосупрессии и фебрильной нейтропении (ANC < 750/мкл по ОКВ).	Применяется при падении нейтрофилов на 7-й день после циклофосамида или лихорадке > 39.2 °C.
Карбонат кальция (CaCO₃) Порошок	½ ч. л. На каждую порцию еды	Кишечный фосфат-биндер и источник кальция при домашнем нежирном рационе.	Связывает фосфор в кишечнике, предотвращая гиперфосфатемию и прогрессирование ХБП.
Рутин (Rutin) Таблетки 500 мг	500 мг PO 1-2 раза в сутки	Флавоноид для стимуляции фагоцитоза липидов в плевральной полости при хилотораксе.	Снижает проницаемость лимфатических сосудов и вязкость плеврального выпота.

❗ КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО НПВС: Нестероидные противовоспалительные средства (Мелоксикам / Метакам, Карпрофен / Римадил, Фирококсиб / Превикокс) **строго противопоказаны** без ведома лечащего нефролога! На фоне ХБП 2 стадии применение НПВС может спровоцировать острое повреждение почек (ОПН) и тяжелый азотемический криз.

2. Расходные материалы и медицинский инструментарий

Наименование	Назначение и Описание	Количество
Электронный градусник	Измерение ректальной температуры (норма 37.5–39.0 °C). При температуре > 39.2 °C на фоне химиотерапии — риск фебрильной нейтропении!	1 шт.
Шприцы без иглы (2, 5, 20 мл)	Для точной дозировки оральных жидких лекарств, выпаивания воды или разведения гепатопротекторов/фосфат-биндеров.	По 5–10 шт.
Впитывающие пеленки	Гигиеническая подстилка при проведении торакоцентеза, форсированного диуреза после фуросемида или тошноте.	1 упаковка
Стерильные салфетки и бинты	Обработка мест пункции или забора крови, защита кожи при необходимости.	1 комплект
Ветеринарный тонометр	Домашний контроль артериального давления при ХБП 2 стадии (целевой уровень систолического АД < 140 мм рт. ст.).	1 шт. (при наличии)

3. Аварийные сценарии: Алгоритм действий при осложнениях

■ СЦЕНАРИЙ А: Одышка и нарастание ЧДД во сне (> 30-35 в мин)

Причина: Накопление хилёзного выпота в плевральной полости, сдавление лёгких.

Действия: 1. Обеспечить полный покой и придать удобную позу (не укладывать насильно на бок!). 2. Применить габапентин для снятия стрессовой тахипноэ. 3. **Срочно доставить в клинику для УЗИ-контролируемого разгрузочного торакоцентеза.**

■ СЦЕНАРИЙ Б: Лихорадка (> 39.2 °C) и вялость на 7-й день после Циклофосфамида

Причина: Пик миелосупрессии (надир) и падение абсолютного количества нейтрофилов (ANC < 750/мкл).

Действия: 1. Срочно сдать утренний клинический анализ крови (ОКВ). 2. При подтверждении нейтропении начать Энрофлоксацин (10 мг/кг SID). 3. При температуре > 39.5 °C или отказе от воды — **экстренная госпитализация на ВВ антибиотики и инфузии!**

■ СЦЕНАРИЙ В: Появление крови в моче (Гематурия) после Циклофосфамида

Причина: Стерильный геморрагический цистит, вызванный раздражением слизистой акролеином.

Действия: 1. Приостановить приём циклофосфамида. 2. Увеличить потребление воды и организовать частый выгул. 3. Связаться с онкологом для замены препарата в схеме (например, на хлорамбуцил).

■ СЦЕНАРИЙ Г: Черный дегтеобразный стул (Мелена) или рвота «кофейной гущей»

Причина: Желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема Преднизолона или уремической гастропатии.

Действия: 1. Срочно отменить Преднизолон. 2. Выдать Омепразол (1 мг/кг). 3. Немедленно связаться с лечащим врачом.

4. Контакты экстренной ветеринарной службы

Специалист / Служба	ФИО врача / Название клиники	Контактный телефон	Адрес / Режим работы
Ветеринарный онколог	_____	+7 (____) _____	_____
Лечащий нефролог	_____	+7 (____) _____	_____
Круглосуточная клиника (ОРИТ)	_____	+7 (____) _____	24/7 (Экстренный торакоцентез)
Зоотакси / Транспортировка	_____	+7 (____) _____	Круглосуточно